Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Salgueiro

R MANOEL FRANCISCO SANTIAGO, 300, Forum Cornélio de Barros Muniz e Sá, Augusto Alencar Sampaio, SALGUEIRO - PE - CEP: 56000-000 - F:(87) 38718779

Processo nº 0000833-44.2022.8.17.3220

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 2ª PROCURADORIA REGIONAL - PETROLINA

SENTENÇA

Vistos etc...

Trata-se de Ação civil pública por Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público de Pernambuco em face do **ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de direito público, com sede no Palácio do Campo das Princesas, Praça da República, s/n, Bairro Santo Antônio, CEP 50.010-928, Recife/PE, objetivando compeli-lo a fornecer a medicação, PREGABALINA 150m, a Sra. Zélia Maria de Jesus, na forma prescrita pelo médico, enquanto for necessário.

Em suma, aduz o requerente que: (...) Conforme o que restou apurado no Procedimento Administrativo nº 01940.000.245/2020, documento acostado no presente pedido, em atendimento realizado no âmbito Ministerial, a Sra. Zélia Maria de Jesus, de 49 anos de idade, portador de artrite reumatoide soronegativo (CID 0: M 06.0), informou que em razão do quadro clínico que se encontra, necessita do uso de PREGABALINA 150mg, 2 (dois) comprimidos por dia, inicialmente, conforme laudo médico, dotado de 15/02/2022 (anexado aos autos). Atualmente, conforme informa o laudo médico, não existe tratamento eficaz fornecido pelo SUS que substitua o medicamento solicitado, tendo em vista que para a atual situação da paciente outros tratamentos com fármacos fornecidos pelo SUS já foram testados. (...).

A inicial foi instruída com receituário médico, documentos pessoais, dentre outros.

Concessão da tutela antecipada, id. 102544844 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=1263265&ca=34aea01206dda5b85729557e27d6e8f31a8d9a82e755427fd5e7c691cd352d19af1bd28ca7b0693eb

Laudo do Natjus, id 103412929.

Citada, a parte promovida apresentou contestação alegando em síntese: (...)2. DO MÉRITO: 2.1. DA TESE FIRMADA PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.657.156 RJ. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO EM DETRIMENTO ÀS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. ESTADO DE

PERNAMBUCO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NN. 2022.01.016262. Ao julgar o RESP nº 1.657.156 RJ, recurso então afetado representativo da controvérsia (tema 106 STJ), a 1ª seção do C. STJ, firmou tese que define, cumulativamente, os seguintes requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). (g.n.). No caso tratado no presente feito, constata-se que a inicial não é instruída com laudo médico circunstanciado que justifique a prescrição em dissonância com a política pública do SUS. A parte demandante, junta declaração médica que apenas informa a necessidade (não fundamentada) de uso do medicamento, sem, no entanto apontar falha nas terapias medicamentosas ofertadas pelo SUS. Desta forma, impõe-se a observância ao art. 927, III, do CPC/2015 e, consequentemente, a improcedência do pedido inaugural. 2.2. DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO MÉDICA NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO. DA EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA, NO ÂMBITO DO SUS, PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA PARTE DEMANDANTE: Inicialmente, deve-se ponderar que embora o laudo médico seja elemento de prova, não pode ser imposto ao Judiciário como se fosse questão puramente de direito, pois não representa prova suprema ou irrefutável. Entender de forma contrária conduziria as decisões judiciais sempre ao deferimento do pleito autoral, subjugando o Poder Público à opinião do médico, independentemente, de ficar comprovado ou não o acerto técnico dessa orientação e transformando o Judiciário em mero homologador de prescrições médicas. Vale explicitar que medicina baseada em evidências (MBE) é um movimento médico que se baseia na aplicação do método científico a toda a prática médica, especialmente àquelas tradicionalmente estabelecidas que ainda não foram submetidas a avaliação sistemática e científica. Evidências significam, aqui, provas científicas. Esse movimento médico contrapõe-se à chamada Medicina Baseada na Autoridade (caracterizada pela exlcusiva opinião do especialista), propondo um saber científico seguro e democrático e propiciando uma prática médica de excelência. Atualmente, a MBE é utilizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS como forma de análise do conhecimento científico médico de todo o mundo, sendo utilizada também por instituições de grande relevância científica da medicina, como o National Health National Health Service - Service -NHS da Grã-Bretanha (Sistema de Saúde Britânico).Também se utiliza da MBE o Sistema Único de Saúde SUS brasileiro, como forma de avaliar as tecnologias médicas que serão disponibilizadas aos usuários do SUS. A Medicina Baseada em Evidências, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (e aplicada de forma definitiva no Sistema SUS desde 2003), estabelece hierarquia entre os estudos científicos disponíveis, conforme a pirâmide das evidências abaixo reproduzida:Percebe-se a partir da pirâmide das evidências que, do ponto de vista científico, a opinião do médico (o receituário médico) representa o mais baixo nível de evidência científica existente, pois é suscetível a subjetividade e viés. Consequentemente, o laudo/prescrição não podem ser tomados como prova absoluta e suficiente do suposto direito do autor/paciente. É o que orienta o CNJ em seus enunciados afetos ao direito à saúde abaixo transcritos: ENUNCIADO N.º 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019) .ENUNCIADO Nº 75 - Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os

requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial; II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas. (g.n.) Nesta esteira o CNJ também orienta aos tribunais do país a consulta a Núcleos de Apoio Técnico em Saúde (NATS) - de disponibilização obrigatória pelos tribunais locais (Resolução CNJ Nº 238 de 06/09/2016) e já existente no âmbito da justiça comum em Pernambuco - a fim de que as decisões sejam arrimadas em critérios técnico, fundados na medicina baseada em evidências: ENUNCIADO Nº 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019).ENUNCIADO Nº 59 - As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais,fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências -MBE. Frise-se que o STF admitiu, a princípio, que a obrigação do Estado (União, Estados, DF e Municípios) restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, eis que o Sistema Único de Saúde filiou-se a corrente da medicina baseada em evidências, adotando, assim, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Por conseguinte, um medicamento ou tratamento em desacordo com o Protocolo deve ser analisado com cautela, visto que tende a contrariar um consenso científico vigente. Confira-se:"A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da "Medicina com base em evidências". Com isso, adotaram-se os "Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas", que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível."(STF, STA 175 AgR/CE , Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, julgado em 17.03.2010). Por essa razão, o Ministro Gilmar Mendes destacou a importância de se privilegiar o tratamento fornecido pelo SUS (STA 175), veja-se: "Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso." (g.n). Diante do exposto, não é razoável o deferimento do pleito autoral, ainda que provisoriamente sem que haja a cabal comprovação de ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e adequação da medicação pleiteada. Frise-se que o SUS oferece alternativas terapêuticas para o medicamento PREGABALINA, sendo fornecido gratuitamente o medicamento GABAPENTINA, nas dosagens de 300 E 400 MG (CÁPSULA). Ademais, cabe ao Poder Executivo o planejamento e a execução de ações preventivas e corretivas na seara da saúde, consoante as limitações orçamentárias existentes. A definição de diretrizes e prioridades e distribuição de recursos não podem ser transferidas ao Judiciário, sob pena de lesão ao art. 2ª da Constituição Federal. Especificamente no caso particular, tal prerrogativa constitucional implica competência para estabelecer critérios à compra de medicamentos e produtos afins, considerando a demanda nos postos/hospitais da rede pública; a disponibilidade financeira e orçamentária e os recursos

destinados à aquisição de medicamentos. Cabe considerar, ainda, que a determinação de aquisição de medicamento pelo Poder Público pressupõe a submissão a regras de direito financeiro e de direito administrativo, além de observância do postulado inserto no inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual as compras efetuadas dependem de licitação prévia, salvo as exceções previstas na legislação (as quais, ainda assim, impõem procedimento próprio caso da dispensa e da inexigibilidade de licitação). Portanto, a atividade administrativa nesse mister se preordena a aplicar adequada e razoavelmente recursos para com a saúde pública, segundo normas e princípios vigentes, de modo a atender, prioritariamente, necessidades previamente identificadas. Adite-se que o direito à proteção da saúde é um direito social, portanto, deve ser entendido e realizado no coletivo e não somente como um direitoindividualizado. "O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada, é o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão."1 É preciso reconhecer que o aceso universal e igualitário à saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, assim como os demais direitos fundamentais, não reclamam exercício ilimitado e incondicionado, e tampouco permite interpretação isolada. Sem a compreensão adequada do interesse coletivo, o Poder Judiciário acaba desequilibrando o sistema, com lesão à participação democrática, à igualdade e ao atendimento da imposição constitucional de existência de uma política de saúde pública. Nesta esteira são os judiciosos votos dos Eminentes Ministros L.R. Barrosp e Fachin, do E. STF, no julgamento do recurso extraordinário representativa da controvérsia RE 566.471/RN, nos quais, ponderam respectivamente que: Segundo o Min. Barroso, "(...)No caso de demanda judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, inclusive de alto custo, o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a fornecê-lo. Não há sistema de saúde que resista a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na política pública. Segundo consignou, para o deferimento, pelo Poder Judiciário, de determinada prestação de saúde, cinco requisitos cumulativos devem ser observados: a) a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente; b) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; c) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; d) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e e) a propositura da demanda necessariamente em face da União, já que a ela cabe a decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos ao SUS. (....) O ministro Edson Fachin deu 1 BARROSO, Luís Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento gratuito de medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial. disponível em http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/medicamentos.pdf. Acesso em 13 dez.2009. parcial provimento ao recurso. Acolheu a alegação de que o Estado-Membro recorrente não poderia ser condenado a custear sozinho o medicamento, por tratar-se de dispensação excepcional. Ressaltou que haveria a necessidade de a União compor o polo passivo da ação. (...) Para aferir tais circunstâncias na via judicial, propôs os seguintes parâmetros: a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva de ofício do agente público por parte do julgador; b) subscrição realizada por médico da rede pública ou justificada impossibilidade; c) indicação do medicamento por meio da Denominação Comum Brasileira ou DCI Internacional; d) justificativa da inadequação ou da inexistência de medicamento ou tratamento dispensado na rede pública; e e) laudo, formulário ou documento subscrito pelo médico responsável pela prescrição, em que se indique a necessidade do tratamento, seus efeitos, e os estudos da medicina baseada em evidências, além das vantagens para o paciente, comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou tratamentos fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia."2 (g.n.). Considerados tais aspectos, percebe-se que a pretensão formulada pela parte autora privilegia unicamente a ela mesma, em detrimento do tratamento de um grande número de pacientes também assistidos pelo SUS e que gozam também do direito à saúde constitucionalmente assegurado (art. 6° e 196 da CF/88). O deferimento da pretensão da Demandante importa flagrante desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5°, caput, e art. 196 da CF/88), pois implica tratamento privilegiado e especial a paciente que se encontra nas mesmas condições de saúde que muitos outros pacientes que buscam adequadamente o tratamento pelo SUS. Com efeito, fica como consequência inexorável que

desatender as prioridades, em detrimento de situações particulares no setor de saúde, finda por comprometer verbas dispensadas àquelas, já que a finitude dos recursos faz com que o atendimento aos casos individuais inviabilize, sobremaneira, por falta de recursos, o tratamento de um grande número de pacientes também assistidos pelo SUS e outros projetos sociais de relevante importância. 2 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/informativo/verInformativo.asp?s1=v. Acesso em 14/10/2016]. Diante disto, considerando a importância de informações técnicas em processos dessa natureza (nos quais, na grande maioria dos casos, as decisões são proferidas apenas com base em receitas médicas apresentadas unilateralmente pelo autor), REQUER o Estado de Pernambuco que esse Juízo envie solicitação deinformações técnicas ao NATS do TJPE. (...).

Réplica a contestação, id 111520767.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora informou não ter interesse na produção de outras e a parte demandada requereu fosse oficiado o Natjus para oferecer parecer, o qual indeferido, vez que já consta nos autos parecer do referido órgão.

É o relatório. Decido.

O feito tramitou regularmente não havendo nulidade a ser declarada, comportando julgamento antecipado, eis que versa apenas sobre questões de direito, não havendo necessidade de produção de prova em audiência.

A pretensão buscada pela parte demandante está amparada pela Constituição Federal vigente, a qual proclama o atendimento à saúde como um **direito de todos e dever do Estado** (artigo 196), bem como que esse atendimento deve ser **integral** (artigo 198, inciso II), compreendendo, por conta disso, o fornecimento de tratamento adequado.

A propósito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

> ***"... O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição da República"*** (Recurso Extraordinário nº 273.839, rel. Min. Celso de Mello). **(GRIFEI)**
>
> No mesmo sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que:

> ***- "... 1) É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde constitucionalmente previsto. 2) Eventual ausência do cumprimento de formalidade burocrática não pode obstaculizar o fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento de portadores de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios necessários ao custeio do tratamento. 3) Entendimento consagrado nesta Corte na esteira de orientação do Egrégio STF. 4) Recurso ordinário conhecido e provido"*** (RMS nº 11.129-0-PR, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins. 2ª T., v.u., j. 02.10.2001).

A par disso, não há que se alegar invasão de matéria de competência do Poder Executivo, pois a pretensão da parte autora é de que se cumpra o dever constitucional do Estado de preservar e recuperar a saúde dos indivíduos (artigo 196, da Constituição Federal), incluindo-se, à evidência, nessa obrigação, o fornecimento de medicamentos àqueles que não têm condições financeiras para adquiri-los.

Não há dúvida, portanto, de que o dever constitucional do Estado, na assistência à saúde, tem caráter concorrente, ou seja, cabe no mesmo grau à União, ao Estado-Membro e ao Município.

Neste caso, a cada um dos entes públicos pode ser exigido no seu dever constitucional, à semelhança do que ocorre na solidariedade, no direito civil, quando a dívida pode ser exigida de cada um dos devedores solidários, no seu todo (artigo 265, do vigente Código Civil).

Na situação sob exame, a parte autora, comprovou por meio de receituários médicos a necessidade do tratamento indicado na exordial e, inclusive, o parecer do Natjus foi favorável ao uso do medicamento pela paciente, Zélia Maria, justificando que várias opções terapêuticas foram utilizadas e no caso da paciente em tela, há o relato da inefetividade dos tratamentos prévios.

O art. 196 da Constituição Federal é esperança dos cidadãos que em momentos de fragilidade de sua saúde, sentem-se abandonados pelo sistema de saúde vigente onde não há quem lhes assegure seus direitos. A burocracia e os interesses em geral não convergem para auxiliá-lo, nesta hora em que ele necessita de amparo. Neste momento, o Poder Judiciário exerce sua função assegurando tal garantia.

Estabelece o art. 196 da CRFB que:

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Desta forma, a União, Estados e Municípios são responsáveis pela saúde das pessoas, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal, sendo da competência comum de todos os entes federativos o “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II, da CF).

Impõe-se ressaltar que a ausência de inclusão do medicamento em listas prévias, quer no âmbito municipal, quer no estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, devendo prevalecer o direito do cidadão à manutenção de sua saúde, o que lhe é constitucionalmente garantido.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Estado de Pernambuco forneça à pessoa de Zélia Maria de Jesus, o medicamento PREGABALINA 150mg, 2 (dois) comprimidos por dia, inicialmente, na forma prescrita pelo médico, condicionando a entrega do medicamento à apresentação, na Secretária de Saúde, de receita médica atualizada a cada 6 (seis) meses tornando definitiva a antecipação da tutela inicialmente deferida.

O não cumprimento da determinação judicial supramencionada importará em bloqueio de valores em contas públicas para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Sem custas e honorários, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Salgueiro, 17.11.2022.

JUIZ DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: JOSE GONCALVES DE ALENCAR
29/11/2022 06:08:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 119910358

22112906082892400000117208323

IMPRIMIR GERAR PDF